

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

Raquel Abad González, Jose Luis Prieto de la Rosa, Braulio Álvarez Martínez.

INTRODUCCIÓN

Se trata de una lesión pulmonar inflamatoria difusa que cursa con daño del epitelio capilar y alveolar. El mecanismo fisiopatológico consiste en un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar que provoca edema alveolar secundario y pérdida del surfactante pulmonar, lo que lleva a la atelectasia de los alveolos y deterioro de la función respiratoria. Debido a su alta mortalidad, que se estima entre un 40-50%, es de vital importancia una sospecha y diagnóstico precoz.

DIAGNÓSTICO

DEFINICIÓN

Se deben de cumplir **3 criterios**:

1	Tiempo de inicio agudo , en la semana posterior a conocerse la alteración clínica o al empeoramiento o aparición de síntomas respiratorios.
2	Imagen torácica (Rx o TC) con opacidades bilaterales no justificable por la existencia de derrame, atelectasias o nódulos.
3	Origen pulmonar del edema no explicable por insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica . En caso de no haber causa probable desencadenante se precisaría una prueba objetiva (ecocardiograma) para excluir edema hidrostático.

El **grado de gravedad** vendrá definido por el grado de hipoxemia medido por la relación entre la PaO₂ y la Fi O₂ con un nivel mínimo de PEEP de 5cmH₂O (presión positiva al final de la espiración).

GRAVEDAD	PaO ₂ / FiO ₂
Leve	200 - 300
Moderado	100 - 200
Grave	<100



Ilustración 1. Rx. Tórax con opacidades bilateral en paciente con SDRA

CAUSAS

Lesión pulmonar directa	Lesión pulmonar indirecta
• Neumonitis aspirativa • Infección pulmonar • Traumatismo torácico grave • Inhalación de humo o tóxicos • Cirugía torácica • Embolia pulmonar	• Shock • Sepsis • Politransfusión (TRALI*) • Pancreatitis • Enfermedad traumática grave • Sobredosis de drogas • Lesión por reperfusión • Transplante de médula ósea • Fármacos

*TRALI: transfusión related acute lung injury.

MANEJO INICIAL:

- Asegurar la vía aérea y vigilancia respiratoria estrecha.
- Monitorización con pulsioximetría continua.
- Oxigenoterapia para $\text{SatO}_2 \geq 90\%$

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- Gasometría arterial.
- Radiografía de tórax PA y lateral.
- Lactato sérico.
- Hemograma, coagulación, bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, ProBNP, PCR, ProCalcitonina.
- Valorar otras pruebas de imagen como TC torácico en función de la sospecha etiológica.

TRATAMIENTO

En Urgencias ante sospecha SDRA:

- Avisar a la UCI para valoración.
- Oxigenoterapia alto flujo.
- Tratamiento de la causa desencadenante.

El tratamiento fundamental es el soporte respiratorio mediante ventilación mecánica, además del tratamiento de la causa desencadenante.

En casos de SDRA leve el soporte ventilatorio podría iniciarse mediante ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con valores de PEEP bajos (inicio de 5 cmH₂O), siempre con volúmenes tidal bajos (5-7 ml/kg (peso ideal)/h) aunque finalmente en todos los casos será necesario un soporte adecuado con ventilación mecánica no invasiva en manos de expertos.

Recordamos los **criterios de intubación orotraqueal:**

- Apnea.
- Deterioro del nivel de consciencia (Glasgow <9).
- Fatiga muscular.
- Taquipnea (FR > 34 rpm).
- Hipoxemia grave con $\text{FiO}_2 > 50\%$.
- Hipercapnia con acidosis respiratoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E, et al. Acute respiratory distress syndrome: The Berlin definition. JAMA - J Am Med Assoc. 2012.
- Montejo González, J., García de Lorenzo y Mateos, A., Marco Garde, P. and Ortiz Leyba, C. (n.d.). Manual de medicina intensiva. 5th ed.
- Gutiérrez Rodero, F. and García Díaz, J. (1991). Manual de diagnóstico y terapéutica médica. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre.